

План за разчитане на рентгенография на гръдна клетка

Първо определете вида на рентгенографията – рентгенография на гръдна клетка, РА проекция, право положение (легнал? АР?). Едно и също ли е името на снимката и на заявката? Обърнете внимание на възрастта и пола на пациента.

I. Правилна ориентация на снимката – ляво-дясно

II. Правилно ли е центрирана снимката

- Всички части на белите дробове трябва да са видими – върхове, основи, косто-диафрагмални синуси (КДС)
- Трябва да се виждат и двата купола на диафрагмите
- Стерналните ръбове на ключиците трябва да са на еднакво разстояние от спинозните израстъци (симетрична графия)
- Ръцете на пациента трябва да са абдуцирани и скапулите да не се наслагват върху белодробните полета

III. Определете дали рентгенографията е технически добре изпълнена (само за снимки на плака, не се отнася за дигитални рентгенографии)

- Нормална експонация – през медиастиналната сянка се виждат първите 4 торакални прешлена
- Субекспонирана графия (бял филм) – нито един прешлен не се вижда през медиастиналната сянка
- Преекспонирана графия (черен филм) – виждат се всички прешлени

IV. Оценка на торакалните структури:

1. Куполите на диафрагмите:

- позиция – нормално са от пето до шесто междуребрие (по предната част на ребрата). Лявата нормално е до 2.5 cm по-ниска от дясната. При 10% от хората диафрагмите са на едно ниво.
- очертания – трябва да са резки и гладки и да се проследяват от единия до другия край.
- КДС – нормално са с остър ъгъл, добре видими
- Субдиафрагмално пространство – без свободен въздух, без патологични засенчвания (например калцификати)

2. Медиастинум

- Позиция на медиастиналната сянка – централно разположена, около 1/3 от нея се разполага надясно и 2/3 наляво от срединната линия
- ширина – нормалната медиастинална сянка се описва като неразширена
- очертания – резки и гладки
- форма – с нормални дъги (описани на картинката)
- сърдечна сянка – размер – до 50% от торакса (кардио-торакален индекс = КТИ). Описание на сърдечните дъги – нормални или с увеличен конвекситет, допълнителни дъги (напр. двойно-контуриране на дъгата на дясно предсърдие от уголемено ляво предсърдие)

- трахея – неразширена, разположена централно, ъгълът на бифуркацията нормално е остър - до около 70 градуса

3. Хилуси

– определи хилусната точка – където горно-дяловата белодробна вена пресича долно-дяловата белодробна артерия

- позиция – нормално между 2^{po} и 4^{то} ребро (по преден контур). Левият нормално е малко по-висок от десния (с до 1 cm)

- структура – само съдове

- оценка на размера на долно-дяловите белодробни артерии – нормално до 17 mm широки

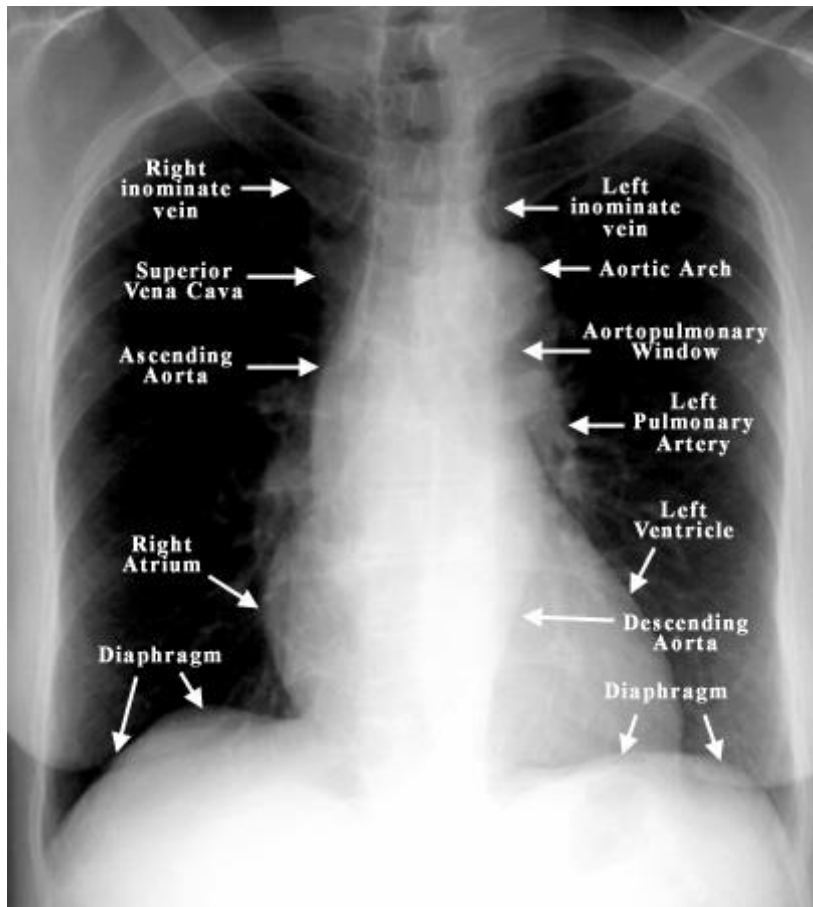
4. Белодробни полета - нормално са видими само сенките на съдове и ребра. Понякога може да се виждат централните клонове на бронхите като пръстенчета, когато са ортоградно срещнати. **Всяка** сянка, която не е от гореспоменатите трябва да бъде описана.

- Горно белодробно поле – над 2^{po} ребро отпред, средно поле – между 2^{po} и 4^{то} ребро отпред, долно поле – под 4^{то} ребро

- Оценка на белодробния съдов рисунок – хиперемия (твърде много съдове), олигемия, венозна конгестия (напр. при сърдечна недостатъчност), рязка промяна в калибъра

5. Костни структури – няма липсващи ребра, няма фрактури, няма патологични сенки по костите

6. Меки тъкани - хомогенни, няма патологични сенки, мастектомия?



Причини за солитарен белодробен нодул:

- **неоплазии**
 - малигнени
 - бронхогенен Са
 - солитарна белодробна метастаза
 - лимфом
 - карциноиден Ту
 - бронхиален карциноиден Ту
 - периферен белодробен карциноиден Ту
 - доброкачествени
 - белодробен хамартом
 - хондром
- **възпалителни**
 - гранулом
 - белодробен абсцес
 - ревматоиден нодул (ревматоиден артрит, грануломатоза на Вегенер)
 - белодробен възпалителен псевдотумор – плазмоклетъчен гранулом
 - кръгла пневмония
 - ТБК – туберкулом
 - Мицетом (аспергилом и др.)
- **вродени**
 - артерио-венозна малформация
 - белодробна киста
 - бронхиална атрезия и изпълнен със секрет бронх
- **други**
 - инфаркт на белия дроб
 - интрапулмонален лимфен възел
 - бронхиален секрет
 - белодробен хематом
 - белодробна амилоидоза
 - нормалния конfluенс на белодробните вени

мимикьори

- сянката на мамилата
- кожна лезия (напр. бенка, брадавица)
- костна фрактура или друга костна лезия
- излив по малкия интерлоб